

43. 肋骨の発達

所要時間：07:22

学習シート

コース概要

このビデオでは、肋骨の胚発生について深く掘り下げ、外胚葉や中胚葉といった要素と胸部構造の形成を結びつけています。複雑性と創発性の概念を提示し、これらのプロセスが臨床症状にどのように影響しうるかを示しています。並行して、肋骨の可動性の重要性が強調され、各肋骨に働きかけるための直接的および間接的なテクニックが提供されます。特に左第4肋骨に関連する感情的な側面が探求され、呼吸運動と感情のバランスとの相関関係が強調されています。

肋骨の発生

肋骨は、複雑な発生プロセスに関連しています。この発生には、**外胚葉**、**中胚葉**、**血管解剖学**、**脳化**、**分節化**、そして**腸**、**体腔**、**心臓**、**肝臓**の発生が関与しています。これらすべての要素が、肋骨系の全体的な出現に貢献しています。

この現象は、しばしば**創発理論**によって説明されます。創発理論は、単純なプロセスがより複雑な構造を生み出す可能性があることを示唆しています。ある段階で複雑さが増大しますが、システムがその複雑さを吸収できなくなる時が来ます。その場合、システムは**カオス**の状態に戻り、再構築される可能性があります。この解体と再構築のプロセスは、経験するのが難しい場合があります。ちょうど、強いプレッシャーの期間の後に**うつ病**が起こる可能性があるのと同じです。

肋骨は、分節化された胸部血管の間の**密化**として形成され、発生35日目頃に始まります。椎体と成長する肋骨弓は、**羊膜腔**内の胚の発生運動に従って伸長します。この**頭部化**、**心臓化**、**肝臓化**、および**境界形成**のプロセスは、肋骨の発生に不可欠です。

45日目から、**骨折**が起こり、**軟骨肋骨関節**が形成されます。この関節は、**鎖骨**の高さで正中線に向かって徐々に中心化します。間葉性凝縮物である胸骨棒も、聴覚の角度、すなわち**縦隔**の高さで結合します。

出生後、**盲腸**はその下降を終え、胚は同様のダイナミクスで発生し続けます。椎骨の周りの構造、例えば**筋節**、**皮膚節**、**硬化節**は、胚の境界形成プロセスと同時に徐々に形成されます。

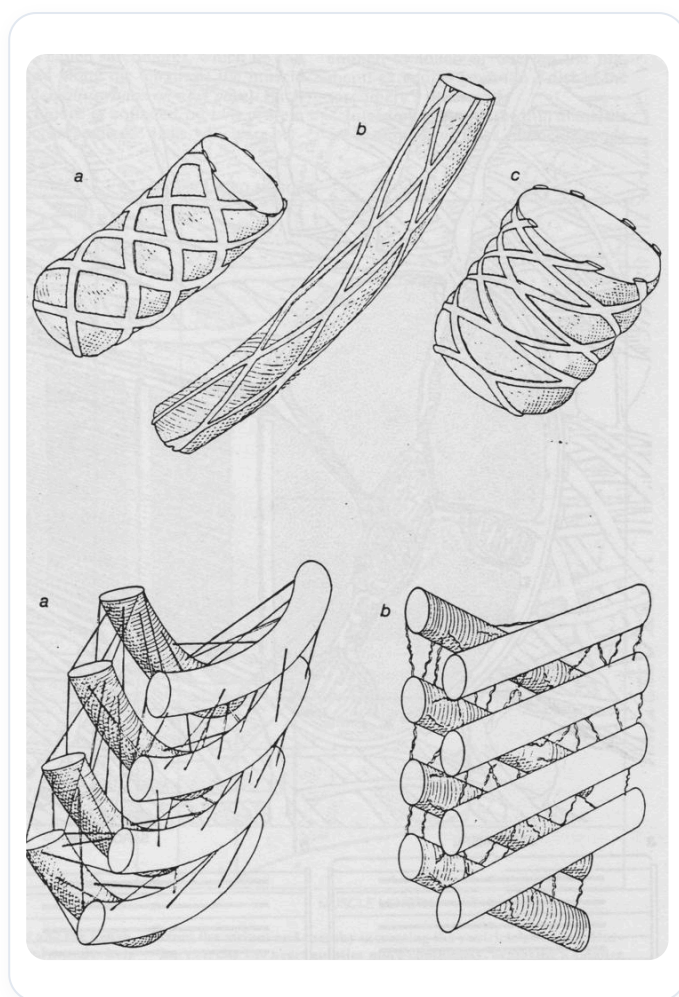
肋骨は臨床現象にも関連しています。例えば、ボクサーの場合、打撃によって**肋間出血**が起こることがあります。肋骨が折れていない場合、それは根本的な問題を示している可能性があります。並行して、肋骨の発生は**壁側胸膜**と**臓側胸膜**の内側ひだを伴い、**胸内筋膜**を形成します。

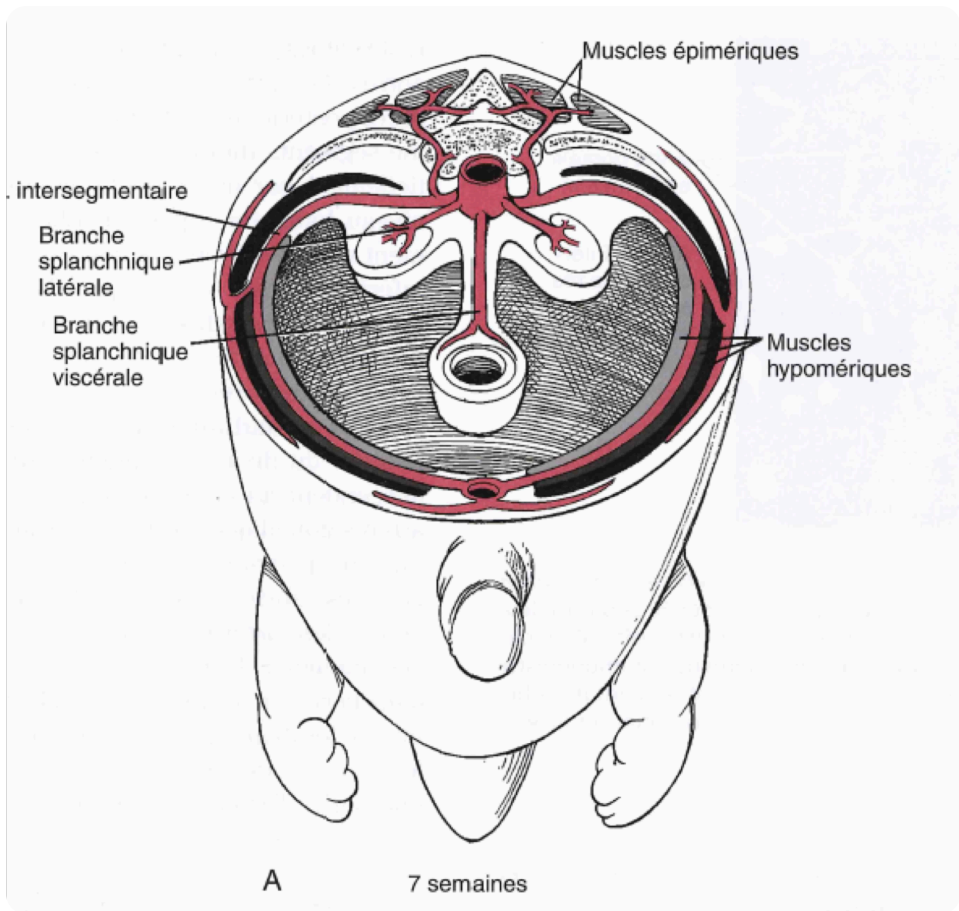
肋骨の可動性に対する働きは不可欠です。このアプローチを深めることで、壁側胸膜と臓側胸膜、特に**肺門**のレベルでつながりを作ることができます。肋骨を解放することで肺が解放され、それによって不可欠な交換が促進されます。

各肋骨に個別に働きかけることも、直接的または間接的なテクニックを使用してより全体的なアプローチを採用することも可能です。肋骨ケージが自由であることは、交換の円滑な流れを可能にするために非常に重要です。

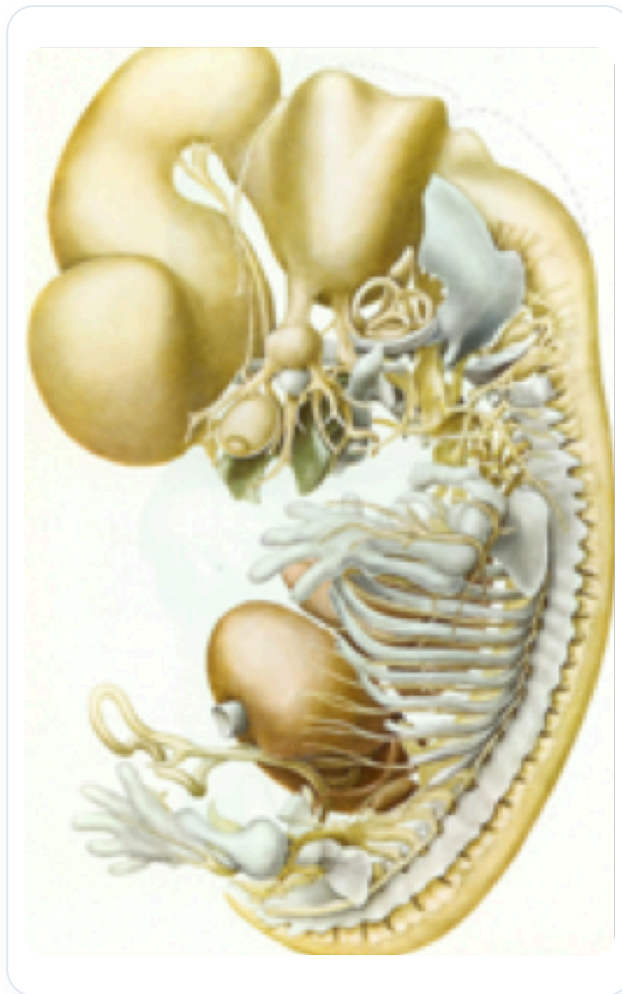
重要な点は、**左の第4肋骨**の感情的な影響です。これはしばしば不安や**心臓前部痛**の現象に関連しています。肋骨は**吸気**と**呼気**と同期して機能します。肋骨が適切に下降しない場合、感情的なブロックにつながる可能性があります。

この領域への働きかけは、肋骨を吸気と呼気の動きに戻し、その位置を修正し、肺門のバランスをとることを含みます。このプロセスは、肋骨系のバランスと機能を回復するために不可欠です。

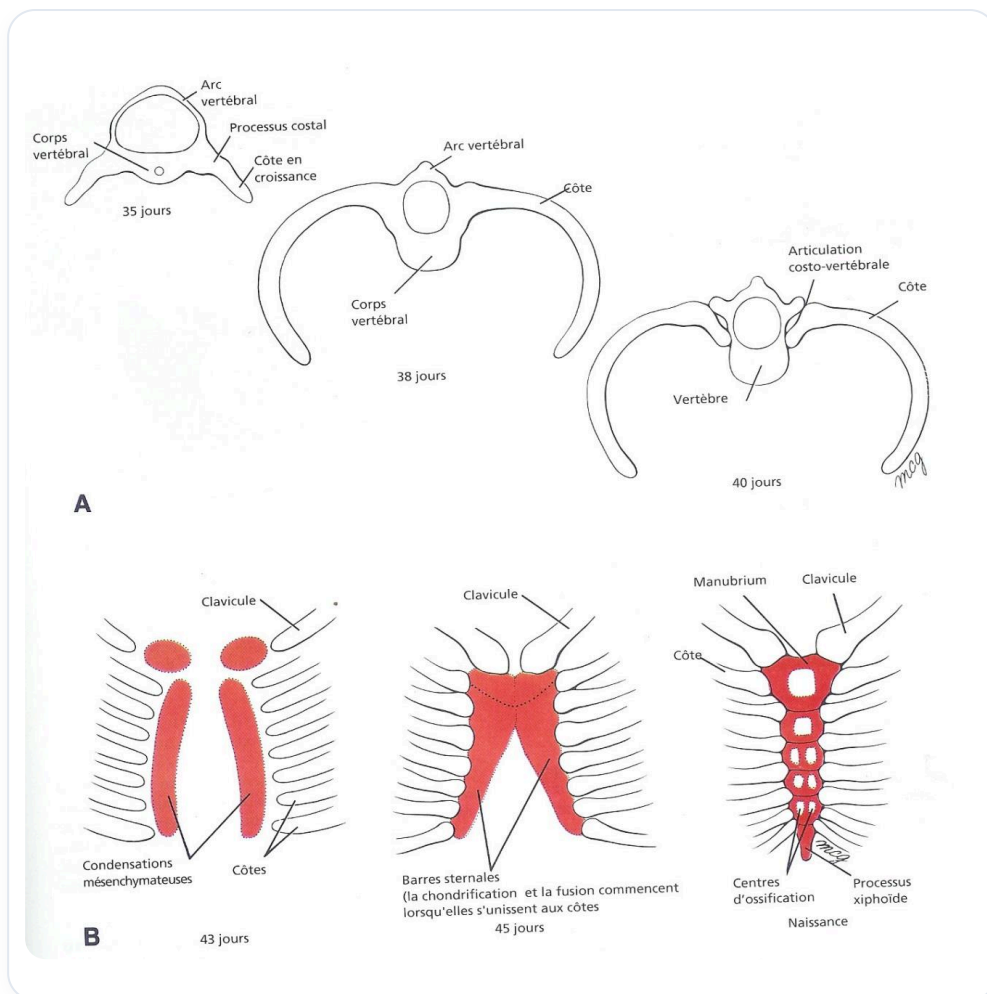




图一 胚7週目、血管



図一 胚の神経系



図一 肋骨と胸骨の発達